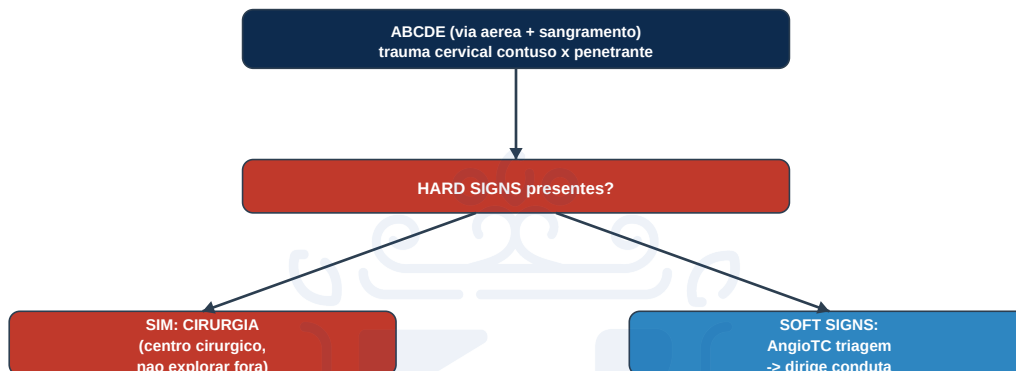


TRAUMA CERVICAL — HARD x SOFT SIGNS

FLUXOGRAMA — SINAIS DECIDEM

CERVICAL PENETRANTE — HARD SIGNS = CIRURGIA



DEFINIÇÃO E ZONAS

O QUE É

- 5-10% de todos os traumas; alta morbimortalidade (estruturas nobres em pequeno espaço)
- 5 sistemas em risco: vascular, respiratório, digestivo, neurológico/ósseo, endócrino
- Penetrante (FAB x FAF, importa o trajeto) x Contuso (raro causar lesão grave; coluna cervical é o mais comum)
- ZONAS: Zona 1 (fúrcula esternal -> cricoide); Zona 2 (cricóide -> ângulo da mandíbula); Zona 3 (ângulo da mandíbula -> base do crânio)

HARD SIGNS x SOFT SIGNS

HARD SIGNS (-> cirurgia)	SOFT SIGNS (-> AngioTC)
Hemorragia incontrolável	Hemorragia pequena
Hematoma em expansão ou pulsátil	Hematoma não expansivo/não pulsátil
Hemoptise/hematêmese maciça	Hemoptise/hematêmese pequena
Choque; déficit neuro de isquemia cerebral; ausência de pulso	Hipotensão responsiva a volume; enfisema subcutâneo
Insuficiência respiratória; ferida 'soprante'	Disfonia; disfagia

RED FLAGS — VIA AÉREA E SANGRAMENTO

ATENÇÃO REDOBRADA

- 1o sempre ABCDE/ATLS — atenção redobrada à VIA AÉREA e ao controle de sangramento
- Ferida soprante / insuficiência respiratória / hematoma expansivo comprimindo via aérea = via aérea ameaçada (IOT precoce/cirúrgica)
- Hard signs = lesão vascular/aerodigestiva grave -> exploração CIRÚRGICA
- Sangramento profuso: passar sonda de FOLEY pelo ferimento e insuflar o balão (compressão/tamponamento local)
- NUNCA explorar o ferimento cervical fora do centro cirúrgico

MANEJO POR ZONA (penetrante, sem hard signs)

Zona	Abordagem preferencial
Zona 1 (base do pescoço)	Arteriografia / endovascular / endoscópico (difícil exposição; pode exigir esternotomia/toracotomia)
Zona 2 (média)	Cirúrgico (melhor exposição) — ou AngioTC guiando, conforme protocolo
Zona 3 (alta)	Arteriografia (difícil exposição; pode exigir luxação da mandíbula)

ESTRATÉGIA ATUAL (no-zone / seletiva)

DA CIRURGIA UNIVERSAL À SELETIVA

- Antigamente: operava-se todo mundo (alta taxa de cervicotomias brancas) ou arteriografia para todos
- Atualmente: HARD signs -> cirurgia; SOFT signs -> AngioTC como triagem
- A AngioTC guia as indicações de endoscopia, broncoscopia, arteriografia e cirurgia
- Manejo cirúrgico: cervicotomia ampla acompanhando o ECM (com extensões por zona)
- Contuso: foco na coluna cervical (imobilização) e na exclusão de lesão vascular (BCVI) por imagem quando indicado

CONDUTA NO PS

PASSOS

- ☐ ABCDE com proteção cervical; priorizar via aérea e controle de hemorragia
- ☐ Classificar: contuso x penetrante; identificar a zona; hard x soft signs
- ☐ Hard signs -> centro cirúrgico (não explorar fora); Foley no ferimento se sangramento profuso
- ☐ Soft signs / estável -> AngioTC para direcionar a investigação
- ☐ Acionar cirurgia (vascular/cabeça-pescoço) e transferir para centro adequado

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Trauma cervical ____ (contuso/penetrante - FAB/FAF), ZONA _____. Hard signs: ____; soft signs: ____.
- Via aérea: ____ (pérvia/IOT/cirúrgica); sangramento controlado: ____ (Foley?).
- AngioTC (se feito): _____. Conduta: cirurgia / arteriografia / observação.
- Solicito centro com cirurgia vascular/cabeça-pescoço e hemodinâmica (estabilizar antes).

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Trauma cervical penetrante com hematoma cervical em expansão e hemorragia incontrolável. Conduta?

- A) AngioTC e observação
- B) Exploração cirúrgica em centro cirúrgico (hard sign), com controle de via aérea
- C) Apenas curativo compressivo e alta
- D) Endoscopia ambulatorial
- E) Explorar o ferimento no leito da emergência

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado é um 'soft sign' no trauma cervical (indica AngioTC, não cirurgia imediata)?

- A) Hematoma pulsátil em expansão
- B) Disfonia ou enfisema subcutâneo sem instabilidade
- C) Choque
- D) Ferida soprante
- E) Ausência de pulso

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Sobre a abordagem atual do trauma cervical penetrante, é correto:

- A) Operar todos os casos
- B) Hard signs vão para cirurgia; soft signs realizam AngioTC como triagem
- C) Arteriografia para todos
- D) Sempre observação domiciliar
- E) Nunca operar

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Diante de sangramento cervical profuso por ferida penetrante, qual medida de controle temporário pode ser usada?

- A) Torniquete cervical
- B) Passar sonda de Foley pelo ferimento e insuflar o balão (compressão local)
- C) Cauterização às cegas
- D) Aguardar a cirurgia sem medidas
- E) Aplicar gelo

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

A Zona 2 cervical (cricoide ao ângulo da mandíbula) tem como abordagem clássica preferencial:

- A) Arteriografia sempre
- B) Acesso cirúrgico (boa exposição) ou AngioTC guiando conforme protocolo
- C) Observação sem exames
- D) Esternotomia de rotina
- E) Luxação da mandíbula de rotina

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Hematoma em expansão + hemorragia incontrolável são HARD SIGNS de lesão vascular/aerodigestiva grave -> exploração cirúrgica em centro cirúrgico, com controle prioritário da via aérea. Nunca explorar fora do CC.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Soft signs (disfonia, disfagia, enfisema subcutâneo, hemorragia pequena, hipotensão responsiva) não exigem cirurgia imediata: realiza-se AngioTC para triar e direcionar (endoscopia/broncoscopia/arteriografia/cirurgia).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A abordagem atual é seletiva: hard signs -> cirurgia; soft signs -> AngioTC de triagem (que guia outras investigações). Abandonou-se a cirurgia/arteriografia universal pela alta taxa de exames/cirurgias negativas.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

No sangramento cervical profuso, pode-se passar uma sonda de Foley pelo trajeto do ferimento e insuflar o balão, promovendo compressão/tamponamento local temporário até o controle cirúrgico definitivo.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A Zona 2 tem boa exposição cirúrgica, sendo a abordagem cirúrgica clássica; protocolos atuais também aceitam AngioTC para guiar a conduta. Zonas 1 e 3 (difícil exposição) favorecem arteriografia/endovascular.

SM24
Suporte ao Plantão Médico